

위축성 위염·장상피화생 — 1년마다 내시경을 보는 이유

오늘 내시경에서 위축성 위염 또는 장상피화생이라는 말을 들으셨다면, 무엇이 문제이고 왜 정기적으로 내시경을 계속 보아야 하는지 설명드립니다.

위축성 위염·장상피화생이란

위축 — 위 점막이 얇아지는 변화입니다. 일종의 노화처럼 이 연배에서 드물지 않게 나타나며, **얼마나 넓은 범위에 퍼졌는지가** 좁은 부위인지보다 훨씬 중요합니다.

장상피화생 — 위축이 진행된 자리에서 위 점막 일부가 **장 점막처럼 바뀐 상태**입니다.

위암 위험, 얼마나 커지나요

장상피화생이 있으면 위암 위험이 올라가는 것은 맞습니다 — 국내 한 연구에서는 없는 경우보다 위암 발생이 **약 11배** 높게 나타났습니다. 다만 **위험이 커진다는 말이 암이 확정된다는 뜻은 아닙니다**. 실제로 암으로 진행하는 경우는 소수이니 지나치게 걱정하지 않으셔도 됩니다.

왜 정해진 간격으로 내시경을 보나요

정기 내시경은 **암을 막는 것이 아니라, 암이 생기더라도 이른 단계에서 빨리 찾는 것**입니다. 국가암검진 기준(**40세 이상 2년마다**)은 누구나 지켜야 하는 최소 간격입니다.

위축·장상피화생의 **범위와 정도**에 따라 이보다 짧은 **1년 간격**을 권해드리는 경우가 있습니다. 얼마나 자주 볼지는 검사 소견을 보고 **진료 때 개별적으로 정합니다**.

생활습관과 헬리코박터

위에 좋은 것을 챙겨 먹기보다, **위에 나쁜 것 — 술·담배·짜고 매운 음식**을 줄이는 것이 더 중요합니다.

마·양배추즙 등이 위축이나 장상피화생을 되돌린다는 근거는 없습니다.

헬리코박터균이 있으면 제균 치료를 받으시는 것이 위암 예방에 도움이 됩니다.

위 용종은 어떻게 하나요

위저선 용종은 착한 용종이라 불릴 만큼 대부분 암으로 진행하지 않습니다. **전형적인 산발성 용종은 대개 추적만 필요 없지만**, 모양이 특이하거나 크면 담당의가 추가 검사를 권할 수 있습니다.

위 용종을 발견해도 **다 떼지는 않는 이유**는, 꼭 필요한 경우에만 절제해 떼 자리가 위산으로 궤양처럼 되는 불필요한 위험을 피하기 위해서입니다.

이런 증상은 검진 예정일까지 기다리지 마세요

검은 변·피를 토함 — 위장 출혈 가능성

원인 모를 체중 감소

음식을 삼키기 어렵거나 걸리는 느낌이 계속됨

계속되는 구토

어지럼·빈혈이라는 말을 들음

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일 · 공휴일 휴진

근거 — ACG 위암 전암성 병변 진료지침(2025) · MAPS III 유럽·아시아 위암 감시 지침(2025) · AGA 위축성 위염 진료 업데이트(2021) · 위저선 용종 관리 지침(2025) · 국내 헬리코박터 파일로리 감염 진단·치료 지침(2025 개정판) · 국가암검진 위암검진 권고안. 내시경 간격은 검사 소견에 따라 담당의가 개별적으로 정합니다. 본 안내는 일반 건강정보이며 개인별 진단·검사 계획을 대신하지 않습니다.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/gi/atrophic-gastritis-im/